

Cette intervention corrige une cicatrice obstruante au col vésical — ou à la jonction entre la vessie et l'urètre après chirurgie de la prostate — entièrement à travers un endoscope, sans incision externe. Le chirurgien ouvre le tissu cicatriciel, puis suture la muqueuse saine par-dessus, afin que la zone cicatrise en restant ouverte.

À propos de cette intervention

Après une chirurgie ou une radiothérapie prostatique, une cicatrice serrée peut se former au **col vésical** — ou au niveau de la jonction entre la vessie et l'urètre — et bloquer le jet urinaire. Inciser simplement cette cicatrice suffit rarement, car la zone peut se refermer en cicatrisant sur du tissu abîmé.

Cette technique — **TUITMR** (incision transurétrale avec réalignement transversal de la muqueuse) — résout ce problème :

- Le chirurgien **incise le tissu cicatriciel** via un endoscope pour rouvrir le canal.
- Puis, à l'aide d'un **outil de suture** introduit par l'urètre, la muqueuse saine est avancée et suturée sur la coupe — comme un lambeau, mais par voie endoscopique.

Les résultats préliminaires sont encourageants : environ **9 patients sur 10** restent ouverts après une seule procédure, et quasi tous après une deuxième — avec un faible risque de fuites urinaires.

Est-ce sans danger ?

Tout se fait par l'urètre, sans les grandes incisions des opérations robotiques ou ouvertes. Les données préliminaires sont prometteuses, notamment pour le faible risque d'incontinence urinaire, qui peut compliquer d'autres reprises dans cette zone. Les risques incluent : saignement, infection urinaire et récurrence du rétrécissement. C'est une technique récente et spécialisée.

COMPRENDRE LES TERMES

Col vésical

L'orifice par lequel la vessie se prolonge dans l'urètre.

Contracture du col vésical

Cicatrice serrée au col vésical bloquant le jet urinaire.

Sténose anastomotique

Rétrécissement cicatriciel au niveau de la jonction vésico-urétrale après chirurgie prostatique.

Urètre

Le canal qui évacue l'urine hors du corps.

Muqueuse

Revêtement interne sain suturé sur la cicatrice pour qu'elle guérisse ouverte.

Cystoscope

La fine caméra par laquelle le chirurgien opère (endoscope).

Incontinence

Fuite urinaire — risque que cette technique cherche à limiter.

Sonde

Tube souple laissé dans l'urètre le temps de la cicatrisation.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? L'intervention est réalisée sous anesthésie : vous ne ressentez rien pendant. Après, attendez-vous à de légères brûlures et des urines rosées pendant quelques jours. Une sonde est laissée en place pour une courte durée. La plupart des patients rentrent le jour même ou après un court séjour.

Comment vous préparer (Avant)

- Réalisée sous **anesthésie générale** — suivez toutes les consignes préopératoires (jeûne, médicaments à suspendre, y compris les anticoagulants).
- Une **analyse d'urine** vérifie l'absence d'infection — toute infection doit être traitée avant l'intervention.
- Prévoyez une **sonde pendant quelques jours** et organisez un retour à domicile accompagné.

Signalez à votre équipe à l'avance si vous :

- Prenez un **anticoagulant** ou avez une infection urinaire en cours
- Avez eu une **chirurgie prostatique, une radiothérapie** ou un traitement antérieur dans cette zone

Déroulement de l'intervention

- 1 Vous êtes endormi sous anesthésie et recevez des antibiotiques.
- 2 Un endoscope est avancé jusqu'à la cicatrice et un guide est mis en place pour la sécurité.
- 3 La cicatrice est élargie et incisée pour rouvrir le canal.
- 4 Un outil de suture passé par l'urètre permet d'avancer la muqueuse saine et de la suturer sur la coupe ; une sonde est ensuite laissée en place.

Après l'intervention

- Retour à domicile **le jour même ou après un court séjour**, avec une sonde pour quelques jours.
- Légères brûlures et **urines rosées** pendant quelques jours : boire suffisamment aide.
- **Évitez les efforts lourds** et les poussées abdominales pendant quelques semaines.
- Un contrôle endoscopique (vers **4 mois**) vérifie que le canal reste ouvert.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- De la fièvre ou des frissons
- Une **impossibilité d'uriner**, surtout après le retrait de la sonde
- De nouvelles **fuites urinaires** importantes
- Un saignement abondant, des caillots ou une douleur qui s'aggrave

TROIS CHOSES À RETENIR

1. C'est une correction sans incision du tissu cicatriciel au col vésical — la cicatrice est ouverte et recouverte de muqueuse saine, avec un faible risque de fuites.
2. Pour vous préparer : respectez le jeûne et les consignes médicamenteuses, traitez toute infection, prévoyez une sonde et un accompagnant pour le retour.
3. Légères brûlures et urines rosées pendant quelques jours sont normales ; un contrôle endoscopique confirme le succès. Appelez sans attendre en cas de fièvre, d'impossibilité d'uriner, de fuites importantes ou de saignement abondant.